生物学的製剤投与下の患者が劇症型 A 群溶連菌に感染した事例

◎川畑 瑚夏[1)]、横川 伊都子[1)]
独立行政法人 地域医療機能推進機構 高岡ふしき病院[1)]

【はじめに】溶血性連鎖球菌は急性咽頭炎などを引き起こす細菌として知られているが稀に劇症型溶連菌感染症として重篤になる場合がある。今回は関節リウマチ治療のため生物学的製剤投与を行っていた患者での一例を経験したので報告する。【症例】75 歳女性。関節リウマチより生物学的製剤を投与され糖尿病で通院中。転倒し顔面を打撲したため A 病院を受診したが問題なく帰宅。その 3 日後より眼瞼が腫れ当院を受診。CT 画像で頭蓋内異常なく自宅での経過観察となった。さらに 3 日後呼吸困難、腰背部痛出現のため再度外来を受診し呼吸不全で入院。発熱は無かった。【身体所見】胸部に発赤と呼吸音減弱を認め、CT 画像では多量の左胸水を認めた。胸水の外観は膿性で細胞数は 144156/μL 内リンパ球 57.5%、多核球 42.5%だった。【微生物学的検査と経過】培養検査は入院時に喀痰、胸水、静脈血で実施。グラム染色の結果、胸水より連鎖状の陽性球菌を認めたため医師へ至急報告を行った。治療では入院日より CEZ が開始された。しかし当日夜間に敗血症性ショックとなり死亡。血液培養は入院 2 日目に陽性転化し胸水同様の連鎖状 GPC が検出された。胸水、血液ともにヒツジ血液寒天培地でβ溶血を伴うコロニーの発育を認めた。連鎖球菌抗原キットを用いて血清型を調べたところ A 群に凝集反応を認めたため医師に報告を行った。後日富山県衛生研究所より *emm89* 型、*speB*、*speC*、*speF* 陽性の結果を受け取った。【考察】今回感染の進行が早く死亡となってしまった要因として 1）生物学的製剤を使用していた患者であったこと 2）検出菌株が強毒素の *speB*、*speC* を有していたことの 2 点が考えられる。【結語】染色結果は迅速に報告されたが経過が早く治療まで至らなかった。患者背景と起因菌の関係性をより注視し正確で迅速な結果報告を行えるように努めていきたい。

連絡先：JCHO 高岡ふしき病院 0763-44-1181（代表）